

Fiktive Patientendaten - ausschließlich für Ausbildung/Simulation Patient/in: Thomas Keller geb.: 17.06.1970 ID: STT-BC-0226-001 Fall-ID: FALL-BC-01

Datum der Untersuchung:

26.02.2026

Tumornachsorgekalender-Nr:

ausgestellt am:

26.02.2026

Überweiser:

Innere Medizin / Pneumologie - Musterklinik

Primärdiagnose:

01/2026

Primärtumor:

C34.1 - Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus), diagnostiziert 26.02.2026 (Aktiv)

Histologie des Primärtumors:

SCLC

TNM bei Erstdiagnose:

cT1b, cN1, cM1b (Cavum Meckeli rechts)

aktuelle Lokalisation:
(z.B. Metastase/Rezidiv)

OL rechts

TNM-Stadium:

UICC IVA

THERAPIEVERLAUF: (Zeitraum, Schema + Zyklen bzw. Dosis bei Radiatio)

18.02.2026 TuKo: 55-jähriger Patient im ECOG-Status 0 mit Erstdiagnose eines kleinzelligen Lungenkarzinoms. Tumorstadium cT2, cN1, cMX, bei unklarer PET-Anreicherung im Bereich der linken Nebenniere. Die Tumorkonferenz empfiehlt eine Abklärung der linken Nebenniere mittels MRT. Sollte sich hier keine Filialisierung ergeben, empfiehlt die Tumorkonferenz die Radiochemotherapie und Vorstellung bei den Kollegen der Strahlentherapie.
MRT der Nebenniere 24.02.2026: Läsion der linken Nebenniere entspricht am ehesten einem lipidreichen Adenom, kein Anhalt für Malignität. Seit 25.02.2026 neoadjuvante Chemotherapie mit Cisplatin / Etoposid; ab 19.03.2026 2. Zyklus mit zusätzlicher Durvalumab-Tx bei Metastase Cavum Meckeli rechts.

ALLGEMEINANAMNESE: (Familienanamnese, Risikofaktoren, Vorerkrankungen, Operationen, usw.)

VE: paroxysmales Vorhofflimmern, Z. n. Kardioversion, arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus Typ 2, Nikotinabusus, Dyslipidämie.

Allergien:

Allergien:

☐ ja

☒ nein

Schrittmacher:

☐ ja

☒ nein

Port/PEG:

☒ ja, Port rechts

☐ nein

Betreuung:

☐ ja

☒ nein

TUMORANAMNESE/aktuelle Beschwerden:

Taubheitsgefühl in rechter Gesichtshälfte, faciale Parese rechts, Doppelbilder.

Fiktive Patientendaten - ausschließlich für Ausbildung/Simulation Patient/in: Thomas Keller geb.: 17.06.1970 ID: STT-BC-0226-001 Fall-ID: FALL-BC-01

STT-Verordnung vom: 26.02.2026 Patient/in: Thomas Keller ID: STT-BC-0226-001

AKTUELLER STATUS:**Karnofsky-Index:**

70% - Arbeitsunfähig, jedoch selbstständig im Alltag. (Karnofsky)

Größe:

179 cm

Gewicht:

92,5 kg

Leicht reduzierter AZ, regulärer EZ, keine Dyspnoe. Cor: HT rein, rhythmisch, keine Geräusche. Pulmo: VAG, keine NG.

BESTRAHLUNGSVERORDNUNG:

Begründung der Strahlentherapie - Indikation:

☐ kurativ☒ palliativ☐ gutartig

Zielvolumen und Dosierung:

DuCoRa-Studie
Filia Cavum Meckeli rechts: 6 x 5,0 Gy
RCIT SCLC OL re / hilär re: ED 1,8 Gy bis GD 63,0 Gy in shrinking-field-Technik
Verlaufs-CT bei 20 Gy

Simultane Systemtherapie:

nein ; X ja, DuCoRa-Studie

Vorbestrahlung
(wann/Lokalisation/Dosis):

X nein ; ja,

☒ Kontakt SozDienst besprochen/Infoblatt ausgehändigt**ausgebender Arzt:**

Dr. Tim Schuster

auswärtige Bildgebung:☐ eingelesen:**Bestrahlungsgerät:**☐ L1☐ L2☒ L3☐ AL/Intrabeam**Termine:**

Planungs-CT / Maske / Markierung:

23.03.2026 10:00 Uhr

Ersteinstellung:

30.03.2026 11:00 Uhr

Labor vor Chemo:

Tagesklinik:

Station:

Chemotherapie (Stat. 12): 13.04.2026 08:00 Uhr

Sonstiges:

Datum: 20.03.2026 12:09:48**erstellender Arzt:**

Dr. Lena Hoffmann

Datum: 20.03.2026 12:22:10**F-/O-Arzt:**

Dr. Tim Schuster



Musterklinik und Poliklinik für Strahlentherapie

CT-Anforderung

Fiktive Patientendaten - ausschließlich für Ausbildung/Simulation Patient/in: Thomas Keller geb.: 17.06.1970 ID: STT-BC-0226-001 Fall-ID: FALL-BC-01

CT-Anordnung vom:

20.03.2026

Anordnender Arzt:

Dr. Lena Hoffmann

DIAGNOSE:

Primär C34.1 - Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus), diagnostiziert 26.02.2026 (Aktiv)

Behandlungsindikation:

SCLC / DuCoRa-Atemstudie

LAGERUNGS- UND SCANVORGABE: REGION:

☐ Schädel ☐ Hals ☒ Thorax ☐ Abdomen ☐ Becken ☒ 4D-Atemstudie ☐ DIBH

☐ Spezielle Anforderung Region:

☒ bei Erreichen einer GHD von

Gy

☒ am:

27.04.2026

☐ Extremitäten:

☐ Ganzkörper-CT:

☒ bitte Arzt hinzurufen

Atemstudie

(Soll ein Flap aufgelegt werden, z. B. Basaliom Kopfregion, muss der Flap durch den Ambulanzzarzt VOR dem Planungs-CT aufgelegt werden. Bei Basaliom Nasen-/Ohrregion bitte statt Flap Planungs-CT mit Moulage.)

Lagerung:

☐ Bauchlage	☐ Belly step
☒ Rückenlage	☐ Pro step
☐ Arme	☐ Knee step
☐ Maske	☐ Schultermarker
☐ Nackenschale	☐ Blasenfüllung
☒ Wing step	☐ Anusmarkierung
☐ Knierolle	☐ Drahtmarkierung
☐ Bluebag	☐ Vaginaltampon
☐ Flap/Moulage	☐ Kopfschale
☐ Zahnschienen	☐ Bellyboard

Datum: 02.04.2026 10:45:20

erstellender Arzt:

Dr. Lena Hoffmann

Datum: 02.04.2026 11:02:00

F-/O-Arzt:

Dr. Tim Schuster

Die Planungs-CT ist Bestandteil der Bestrahlungsplanung und der dazugehörigen Patientenaufklärung.

Fiktive Patientendaten - ausschließlich für Ausbildung/Simulation Patient/in: Thomas Keller geb.: 17.06.1970 ID: STT-BC-0226-001 Fall-ID: FALL-BC-01

Datum der Untersuchung: 23.03.2026

Gewicht Patient:

92,5 kg

Ganzkörper-CT:

☐ Patientendurchmesser < 30 cm

☐ Patientendurchmesser > 30 cm (Probeliegen bei Erstgespräch)

Referenzpunkt:

Tischhöhe:

12 cm

Lagerung:

☐ Bauchlage	☐ Belly step
☒ Rückenlage	☐ Pro step
☒ Arme: Wing step	☐ Knee step
☐ Maske	☐ Schultermarker
☐ Nackenschale	☐ Blasenfüllung
☒ Wing step / Ring	☐ Anusmarkierung
☐ Knierolle	☐ Drahtmarkierung
☐ Bluebag	☐ Vaginaltampon
☐ Flap/Moulage	☐ Kopfschale
☐ Zahnschienen	☐ blaue Matte
☐ Bauchpresse	☒ 4D-Atemstudie: Atemstudie nach ärztlicher Rücksprache
☐ schiefe Ebene	☐ Bellyboard
☐ DIBH	
☐ Name Atemkurve	

Atemstudie / 4D-CT nach ärztlicher Rücksprache. Thoraxlagerung in Rückenlage, Arme im Wing step.

Nach Durchführung der CT verpflichtende Kontrolle (DA)

kontrolliert:

1. Wirbelsäule optisch und im Scout gerade gelagert?
Keine metallischen Lagerungshilfen im Bild?



2. Ref-Markierung (Bleikugeln) im CT-Schnitt auf einer Schicht?



3. Blasen-/Rektumfüllung kontrolliert?



4. KM-Reste Darm/Blase -> Arzt dazu



5. Ganzer Patientenumfang wird rekonstruiert?



6. Bei Kontroll-CT: Was wurde mit Bleikugeln markiert?



Datum: 23.03.2026 10:42:00

MTRA: Anna Vogt

Datum: 23.03.2026 11:05:00

F-/O-Arzt: Dr. Miriam König